

CAPÍTULO 7.2

Hipopituitarismo

PERFIL EUNACOM 1.03.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hipotiroidismo

Clínica

- Astenia, adinamia (síntomas inespecíficos pero frecuentes)
- Intolerancia al frío
- Constipación
- Piel seca, caída de la cola de las cejas
- Bradicardia, hipotermia (casos graves)
- Hiporreflexia
- Voz ronca, macroglosia

Alteraciones de laboratorio asociadas

TABLA 7.2.1: EXAMEN VS HALLAZGO		
EXAMEN	HALLAZGO	
Hemograma	Anemia: Generalidades	Anemia macrocítica (↑ VCM)
Sodio	Hiponatremia (euvolémica / VEC normal)	
Bilirrubina	↑ Bilirrubina indirecta (ictericia neonatal tardía)	
Lípidos	Hipercolesterolemia (a veces hipertrigliceridemia)	
CK	↑ (miopatía hipotiroidea / mialgias)	

Diagnóstico

TABLA 7.2.2: TIPO VS TSH		
TIPO	TSH	T4 LIBRE
Primario	↑ (alta)	↓
Secundario (hipofisario)	↓	↓
Subclínico	↑	Normal

- **Screening:** TSH (barato, sensible) - **Confirmación:** TSH + T4 libre
- Si secundario → **RNM hipófisis**

NOTA CLÍNICA

Hipotiroidismo asintomático ≠ hipotiroidismo subclínico. El subclínico exige dos condiciones: TSH ↑ + T4 libre **normal**. Un paciente con TSH ↑ + T4 libre ↓ (aunque esté asintomático) = hipotiroidismo primario, no subclínico.

Tratamiento

- **Levotiroxina (T4)** VO — en ayunas 30 min antes del desayuno
- Dosis inicial estándar: **1,6 µg/kg/día** (≈ 100 µg en un adulto de 60 kg)
- Control: TSH cada **6 semanas** hasta normalizar → luego c/6 meses → c/1 año

Objetivo de TSH según grupo

TABLA 7.2.3: GRUPO VS TSH OBJETIVO	
GRUPO	TSH OBJETIVO
Adulto general	0,4–4 mUI/L
Adulto mayor > 75 años	3–6 mUI/L (rango más permisivo)
Embarazada	0,4–2,5 mUI/L (más estricto)

Ajuste de dosis según TSH de control

TABLA 7.2.4: TSH DE CONTROL VS INTERPRETACIÓN		
TSH DE CONTROL	INTERPRETACIÓN	CONDUCTA
< 0,4 (ej. 0,2)	Dosis excesiva (hipertiroidismo subclínico iatrogénico)	Bajar dosis
0,4–4 (ej. 2,4)	Dosis adecuada	Mantener
> 4 (ej. 8,4)	Dosis insuficiente	Subir dosis

Excepciones de inicio de dosis (bajar a 25–50 µg)

- **Cardiópatas** y **adultos mayores** → riesgo de arritmias con dosis altas
- Ir subiéndolo de a poco

Seguimiento del hipotiroidismo secundario

→ No sirve la TSH (ya está baja por la patología hipofisaria) → Seguimiento con **T4 libre**

Hipotiroidismo Subclínico

- **Definición:** TSH ↑ + T4 libre **normal** + asintomático
- **Regla general:** **observar** (no tratar)
- **Controles:** 1 vez al año con TSH; más frecuente si hay anticuerpos anti-TPO (+)

Excepciones ("Las D"): tratar igual que hipotiroidismo

TABLA 7.2.5: CONDICIÓN VS DETALLE	
CONDICIÓN	DETALLE
TSH > 10	Independiente de T4 libre o síntomas
Demencia (adulto mayor)	Ensayo terapéutico
Dislipidemia	Cualquier tipo
Depresión	(controversia, pero se suele tratar)
embaraDa (embarazada)	Siempre tratar en embarazo

Coma Mixedematoso

- Forma más grave del **hipotiroidismo**. Mortalidad: **30–50%**
- **Clínica:** hipotiroidismo grave + **compromiso de conciencia** + mixedema generalizado + hipotermia + bradicardia + bradiapnea + hiponatremia + hipoglicemia

Tratamiento — Orden Estricto

- **Soporte general:** ventilación mecánica si es necesario, glucosa si hipoglicemia, SF EV
- **Corticoides EV** (hidrocortisona) → **primero siempre**, evitar desencadenar crisis suprarrenal
- **Levotiroxina EV** (dosis de carga: 400 µg EV → luego dosis altas) o por SNG si no hay EV
- **T3 EV** (triiodotironina) — una de las pocas indicaciones para usar T3 directamente

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Igual que en el hipopituitarismo: **corticoides ANTES de la levotiroxina**. Si se da T4 sin cortisol → puede desencadenarse una crisis suprarrenal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 34 años con antecedente de parto complicado con hemorragia masiva postparto (atrapamiento de placenta y shock hipovolémico) hace 8 meses. No logró amamantar por agalactia y no ha vuelto a reglar. Presenta astenia severa, intolerancia al frío y pérdida de vello axilar y pubiano."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Síndrome de Sheehan (Necrosis isquémica hipofisiaria postparto): hipopituitarismo secundario a shock hipovolémico puerperal. Afecta secuencialmente Prolactina (agalactia precoz), Gonadotrofinas (amenorrea), TSH (hipotiroidismo secundario) y ACTH (insuficiencia suprarrenal secundaria). Tratamiento: reemplazo hormonal de por vida (Levotiroxina + Hidrocortisona; Hidrocortisona siempre antes o concomitante con T4 para evitar crisis adrenal).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa más frecuente de hipopituitarismo: tumores hipofisiarios. El síndrome de Sheehan es el infarto hipofisiario post-hemorragia puerperal.
- La clínica incluye síntomas de insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, hipogonadismo, diabetes insípida, enanismo (niños) y agalactia (puérperas).
- Diagnóstico: pruebas hormonales (tropinas bajas + hormonas finales bajas) + RMN de hipófisis. Silla turca vacía sugiere infarto previo.
- Tratamiento: suplementar hormona final. ORDEN: 1° cortisol, 2° desmopresina, 3° levotiroxina, 4° reemplazo hormonal sexual, 5° GH solo en niños.
- El cortisol SIEMPRE se suplementa primero, antes de la levotiroxina, para evitar crisis suprarrenal.
- Los tumores hipofisiarios se asocian a hemianopsia heterónima bitemporal por compresión del quiasma óptico.
- El síndrome de Sheehan cursa con amenorrea + agalactia post-hemorragia puerperal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPOPITUITARISMO)**PREGUNTA 1**

Mujer de 28 años consulta por ausencia de lactancia materna, amenorrea persistente a 3 meses del parto y astenia. Tiene antecedente de hemorragia postparto severa que requirió transfusión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Hipotiroidismo primario
- B)** Síndrome de Sheehan
- C)** Prolactinoma
- D)** Depresión postparto
- E)** Insuficiencia suprarrenal primaria

PREGUNTA 2

En un paciente con diagnóstico de panhipopituitarismo, ¿cuál es la primera hormona que se debe suplementar antes de iniciar levotiroxina?

- A)** Hormona de crecimiento
- B)** Testosterona
- C)** Desmopresina
- D)** Cortisol (hidrocortisona)
- E)** Prolactina

PREGUNTA 3

Hombre de 45 años con cefalea progresiva, disminución de campo visual bitemporal, astenia, intolerancia al frío y disfunción eréctil. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más apropiada?

- A)** Solicitar solo TSH y T4 libre
- B)** Pruebas hormonales completas + RMN de hipófisis
- C)** Ecografía tiroidea
- D)** Campimetría visual solamente
- E)** Iniciar levotiroxina empíricamente

RESUMEN: HIPOPITUITARISMO

El hipopituitarismo se define como la hipoproducción de hormonas hipofisiarias. Sus causas más frecuentes son los tumores hipofisiarios que destruyen la hipófisis al crecer, seguidos de la apoplejía hipofisiaria (infarto de un tumor), traumatismos, neurocirugía, radioterapia, el síndrome de Sheehan (infarto hipofisiario post-hemorragia puerperal) y la hipofisitis autoinmune. La clínica incluye síntomas de insuficiencia suprarrenal (náuseas, astenia, crisis suprarrenal), hipotiroidismo (intolerancia al frío, constipación, piel seca), hipogonadismo (disfunción sexual, disminución de libido), diabetes insípida (poliuria, polidipsia, hipernatremia), enanismo en niños, y agalactia en puérperas. El diagnóstico se realiza con pruebas hormonales que muestran disminución de tropinas y hormonas finales, seguido de RMN de hipófisis. Una silla turca vacía sugiere infarto hipofisiario previo. El tratamiento consiste en suplementar las hormonas finales en orden: primero cortisol (para evitar crisis suprarrenal al iniciar levotiroxina), segundo ADH (desmopresina), tercero levotiroxina, cuarto terapia de reemplazo hormonal sexual (testosterona en hombres, estrógenos +/- progesterona en mujeres), hormona de crecimiento solo en niños, y para la falta de prolactina simplemente leche de fórmula.